

Cirugía de suspensión vaginal

Información para el paciente · Elevar la parte superior de la vagina con su propio tejido — sin malla **WARWIKI**

La cirugía de suspensión vaginal repara el prolapso de la **parte superior de la vagina o del útero** al volver a sujetarla a sus propios ligamentos pélvicos fuertes — con su **tejido nativo**, sin malla. Se hace por completo a través de la vagina, sin incisión abdominal, y es una forma duradera y sin malla de restaurar el soporte y la profundidad vaginal.

Acerca de este procedimiento

La parte superior de la vagina se cose a un ligamento firme de la pelvis para sostenerla. Las dos versiones comunes son:

- **Suspensión del ligamento uterosacro (USLS)** — fijada a los ligamentos uterosacros, en lo profundo de la pelvis
- **Fijación del ligamento sacroespinoso (SSLF)** — fijada al ligamento sacroespinoso, hacia el lado

Ambas usan **su propio tejido** (puntos permanentes) y evitan la malla. Suelen combinarse con reparaciones de la pared anterior o posterior y, cuando se extrae el útero, se hacen al mismo tiempo.

Cómo se compara

Frente a la **sacrocolpopexia** (que eleva la vagina con malla abdominal), la suspensión vaginal evita la malla y el abdomen; la sacrocolpopexia puede ser algo más duradera. Su cirujano le ayudará a sopesar las ventajas y desventajas.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Ápice / cúpula

La parte superior de la vagina, que puede caer con el prolapso.

Suspensión

Volver a sujetar la parte superior de la vagina a un ligamento fuerte.

USLS

Suspensión del ligamento uterosacro.

SSLF

Fijación del ligamento sacroespinoso.

Tejido nativo

Su propio tejido — esta reparación no usa malla.

Prolapso de cúpula

Caída de la parte superior de la vagina, a menudo tras la histerectomía.

¿LE DOLERÁ? Se hace con anestesia, por lo que no siente nada durante el procedimiento, y no hay incisión abdominal. Con la versión sacroespinosa, algunas personas notan **molestia en la nalga o la parte superior de la pierna** durante unos días a semanas mientras la zona sana — suele resolverse por sí sola.

Cómo prepararse

- Siga sus **instrucciones de anestesia** (ayuno; suspenda los anticoagulantes según le indiquen).
- Una evaluación preoperatoria; pueden combinarse otras reparaciones o un procedimiento antiescape.
- No fume; organice transporte y ayuda en casa.

Qué sucede

- 1 Usted está bajo anestesia; se dan antibióticos.
- 2 Por la vagina, la parte superior de la vagina se cose a un ligamento pélvico fuerte.
- 3 Se hacen las reparaciones de pared adicionales planeadas.
- 4 Se colocan brevemente una sonda y, a veces, un taponamiento vaginal.

Después de la cirugía

- A casa el mismo día o tras una noche; manchado/flujo leve es normal.
- **Evite levantar peso, hacer fuerza y las relaciones sexuales unas 6 semanas.**
- La molestia en la nalga (con SSLF) suele ceder en unas semanas; mantenga las heces blandas.

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos, o sangrado abundante
- **No puede orinar**, o empeora el dolor pélvico
- **Dolor intenso o punzante en nalga/pierna**, o nuevo entumecimiento

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La suspensión vaginal eleva la parte superior de la vagina con sus propios ligamentos — duradera, sin malla y a través de la vagina.
2. Las versiones comunes son USLS y SSLF; la sacrocolpopexia es la alternativa con malla/abdominal si desea comparar.
3. Evite levantar peso y el sexo ~6 semanas. Puede haber dolor leve en la nalga con SSLF; llame si hay fiebre, sangrado abundante o dolor intenso en pierna/nalga.